Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Avenida Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53)3026-8500 - Balcão Virtual WhatsApp (53) 99705-0690 - Email: frpelotas5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5027361-39.2024.8.21.0022/RS

AUTOR: CRISTIANA BUBOLZ BULL

RÉU: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

CRISTIANA BUBOLZ BULL ajuizou a presente *ação cominatória* em face de **CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**. Disse ser beneficiária do plano de saúde disponibilizado pela parte ré, figurando como cônjuge de associado. Relatou ser portadora de *Doença de Crohn* (CID K50), necessitando fazer uso dos fármacos *Mecasol MMX* 1.200mg, duas vezes ao dia, assim como *Procimax* 40mg, uma vez ao dia. Referiu ter a parte demandada disponibilizado o medicamento *Mecasol* no período entre 20/02/2015 a 09/02/2020, quando cessou sob o argumento de que tal *não fazia parte de seu Programa de Assistência Farmacêutica.* Afirmou ter pleiteado o medicamento *Procimax* em 16/07/2024, recebendo resposta negativa. Teceu considerações normativas. Em sede de tutela antecipada, pediu fosse a ré instada a fornecer os medicamentos. Ao final, a confirmação da decisão liminar por sentença definitiva de mérito. Juntou documentos.

Recolhidas as custas iniciais.

Determinada a apresentação de emenda à inicial, diligência atendida, inclusive com juntada de documentação complementar.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela. A parte autora interpôs agravo de instrumento, desprovido.

Citada, a parte ré contestou. Preliminarmente, insurgiu-se ao pedido autoral, afirmando tratar-se de pretensão genérica e sem limitação de prazo. No mérito, relatou ser indevida a incidência do CDC ao caso concreto. Disse que o art. 10 da Lei n. 9.656/98 exclui da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, assim como a cláusula 18ª do instrumento contratual pactuado exclui da cobertura assistencial do plano de saúde os medicamentos de uso domiciliar diversos daqueles constantes na relação de fármacos abonáveis, na qual não se encontram aqueles pleiteados. Discorreu sobre a validade das cláusulas restritivas, com apontamentos normativos e jurisprudenciais. Protestou pela improcedência do pedido. Juntou documentos.

Sobreveio réplica.

Em saneamento, desacolhida a preliminar, mantida a distribuição do ônus da prova e instados os litigantes acerca do interesse na dilação probatória, nada sendo pleiteado.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Relatado, DECIDO.

O contexto fático e jurídico que se apresentava quando do exame do pedido liminar não se alterou no curso do processo, modo que me valho dos argumentos empregados para indeferimento da antecipação de tutela como razões de decidir, modo a evitar indesejável tautologia (evento 16, DESPADEC1):

> ***2.*** *Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, em tutela de urgência, requer "o fornecimento integral dos medicamentos de referência Mesacol MMX 1.200mg, 60 comprimidos por mês, bem como Procimax 40mg, 30 comprimidos por mês".*
>
> *Para tanto, relata ser portadora da Doença de Crohn, além de apresentar Transtorno de Ansiedade associado à Depressão, necessitando, por indicação médica, utilizar os medicamentos Mesacol MMX 1.200mg, duas vezes ao dia, e Procimax 40mg, uma vez ao dia. No entanto, os medicamentos foram negados pela parte ré sob as seguintes justificativas: o medicamento Mesacol não faz parte do seu Programa de Assistência Farmacêutica, e o medicamento Procimax não faz parte da Lista de Materiais e Medicamentos Abonados pela CASSI.*
>
> *Pois bem.*
>
> *Consoante dispõe o art. 300 do CPC, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.*
>
> *No caso em tela, a parte autora demostra sua vinculação com o plano de saúde (evento 1, DOC19) e o requerimento dos medicamentos indicados pelo médico que a acompanha, conforme laudos juntados em evento 1, DOC6 e evento 1, DOC15, bem como a negativa de fornecimento dos referidos medicamentos pela requerida (evento 1, DOC8 e evento 14, DOC2).*
>
> *Com efeito, a demandada negou a cobertura do medicamento perquirido pela parte autora sob o argumento de que os mesmo não fazem parte do seu Programa de Assistência Farmacêutica e da Lista de Materiais e Medicamentos Abonados pela CASSI.*

Ocorre que, a Lei n.º 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde - LPS), em seu art. 10, VI[1], prevê a exclusão de cobertura dos medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos. Portanto, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, que não é antineoplásico, não há, em um juízo de cognição sumária, dever de cobertura pelo plano de saúde, o que afasta a probabilidade do direito.

A indicação médica de utilização dos fármacos, por si só, não é suficiente para o deferimento liminar da medida postulada. O fornecimento de todos os medicamentos necessários ao tratamento dos beneficiários de planos de saúde representaria a materialização de uma situação ideal, porém, tratando-se de uma relação contratual devem ser respeitados os limites da contratação, até melhor e ampla instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA DERMATOMIOSITE.MEDICAMENTO DOMICILIAR. RITUXIMABE. ROL DA ANS. PLATAFORMA E-NATJUS. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. - No caso, ausentes os requisitos da tutela provisória, neste momento processual, pois a parte autora não comprova que o medicamento pleiteado encontra-se no rol da ANS como de cobertura obrigatória para a doença que lhe acomete e, ainda, não demonstra existir comprovação da eficácia do tratamento ou recomendação da Conitec. Ainda, em acesso à plataforma E-NatJus inexiste qualquer nota técnica ligando a doença do autor ao medicamento pleiteado, o que inviabiliza outra conclusão que não seja da inexistência de comprovação da eficácia do tratamento ou recomendação. - ***Afora isto, a Lei n.º 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde - LPS), em seu art. 10, VI, prevê a exclusão de cobertura dos medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos. Portanto, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não antineoplásico, não há dever de cobertura pelo plano de saúde, o que também afasta a probabilidade do direito. -*** *Até melhor e ampla instrução processual, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória, pois ausentes seus requisitos legais, neste momento processual e diante das provas até o momento juntadas. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50631719320248217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 09-03-2024). Grifei*

Além disso, a parte autora não demostrou a impossibilidade da continuidade no pagamento dos medicamentos, o que não demostra a urgência alegada.

Isto posto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida.

E complemento com as razões ulteriormente elencadas pelo TJRS por ocasião do exame do agravo de instrumento interposto pela parte requerente (processo 5240224-61.2024.8.21.7000/TJRS, evento 18, RELVOTO1):

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a agravante postula o fornecimento dos medicamentos Mesacol MMX 1.200mg e Procimax 40mg, eis que foi diagnosticada com Doença de Crohn, além de apresentar Transtorno de Ansiedade associado à Depressão.

Assim, devem ser observadas de modo prioritário as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, observado o disposto na Lei nº 9.656/98, nos seguintes termos:

*"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
[...]
*§ 1º **As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS**. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
[...]

***§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação**. [grifei]*

Neste norte, tem-se que o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS possui a função de garantir e publicizar o direito dos beneficiários dos planos de saúde, abrangendo os tratamentos, procedimentos e medicamentos considerados indispensáveis, seja ao diagnóstico ou à cura da enfermidade.

No que se refere aos medicamentos de uso domiciliar, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, elencou somente os medicamentos antineoplásicos dentre as coberturas obrigatórias, incluídos aí os medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.

Ilustro:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

*I - **quando incluir atendimento ambulatorial**:*

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

*c) **cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes**;* ***(Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)*** *[grifei]*

Todavia, não se trata aqui de medicamento antineoplásico ou de uso exclusivamente ambulatorial, pelo que não há dever de cobertura deste pelo plano de saúde.

Em casos análogos ao presente, já se pronunciou esta 6ª Câmara Cível:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. SAXENDA 6MG. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA INDEVIDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual a parte autora busca cobertura do medicamento denominado Saxenda 6mg, porquanto acometida de Acúmulo de Gordura no Corpo (CID E66), julgada improcedente na origem. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. No caso em tela, a autora foi diagnosticada com Acúmulo de Gordura no Corpo (CID E66) e necessita utilizar o medicamento Saxenda 6mg, nos termos do laudo médico acostado aos autos, para uso domiciliar. Muito embora vigente a alteração legislativa decorrente do advento da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a referida lei é clara ao estabelecer os requisitos para coberturas que vão além das previsões do Rol da ANS, sendo que, na espécie, não se está a amparar a negativa meramente por ausência de previsão do rol, mas, antes disso, por haver dispositivo legal que prevê, de forma expressa, a não obrigação de cobertura assistencial para medicamentos de uso domiciliar que não forem antineoplásicos, bem como medicação a ser utilizada utilizada quando houver atendimentos em Home Care.Nesse contexto, o medicamento pleiteado não se encaixa nas hipóteses de exceção expressamente previstas no 10 da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 465/2021 para a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, de modo que descabida a cobertura pretendida.Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA" (Apelação Cível, Nº 50015511420228210093, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DO FÁRMACO OZEMPIC. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DA EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PELA SAÚDE SUPLEMENTAR ESTÁ ADSTRITA AOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), À MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E AOS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM, HIPÓTESES NAS QUAIS NÃO SE ENQUADRA O CASO DOS AUTOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DA EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. O STJ JÁ TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO QUE "NA SAÚDE SUPLEMENTAR, É LÍCITA A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DE UNIDADE DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS, A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível, Nº 51989414020238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-07-2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS, DE REGRA, TAXATIVO. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA. 1. Segundo prevê a Lei nº 9.656/98, devem ser observadas as coberturas definidas na Resolução Normativa nº 465/01, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que apresenta as Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar. O rol de coberturas para os planos de saúde, em regra, é taxativo, conforme tese fixada pelo egrégio STJ nos autos do ERESP 1.886.929. 2. A Lei nº 9.656/98, quanto aos medicamentos e insumos de uso domiciliar, incluiu dentre as coberturas obrigatórias apenas aqueles destinados a tratamento antineoplásico, sendo lícita a negativa da operadora, uma vez que tanto o insumo como os respectivos materiais são de uso domiciliar e não estão incluídos nas exceções legais. 3. O aparelho medidor de glicose não está contemplado no rol da ANS, bem como não há circunstância excepcional justificadora de cobertura extra rol, além da existência de Notas Técnicas extraídas do sistema e-Natjus, ferramenta lançada para auxiliar na solução das controvérsias, como apoio ao judiciário, pelo CNJ e o Ministério da Saúde -, desfavoráveis à utilização. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO." (Apelação Cível, Nº 50107917520238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-03-2024).

Por tais razões, entendo ser o caso de negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

*Ante o exposto, **voto por negar provimento** ao agravo de instrumento.*

Neste sentido, ainda que me compadeça do quadro de saúde da parte autora, as operadoras de plano privado de assistência à saúde não estão obrigadas ao fornecimento de medicamentos fora do regime de internação hospitalar, exceto, claro, para tratamento antineoplásico, conforme art. 12, inc. I, 'c', e inc. II, 'g', da Lei nº 9.656/98, ou quando houver disposição contratual em sentido contrário. O tratamento ora pretendido não se enquadra como antineoplásico, bem assim não há cláusula prevendo a respectiva cobertura.

Pelo exposto, não há embasamento legal que justifique a condenação da parte ré à obrigação de fazer requerida pela parte autora.

Posto isso, forte no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente pretensão.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em prol do procurador da parte ré, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado (IPCA) da causa (R$ 10.452,48), conforme § 2º do art. 85 do CPC.

Intimadas as partes.

Interposto apelo e/ou recurso adesivo, independentemente de comando judicial, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Apresentadas as contrarrazões ou certificada a sua não apresentação, remetam-se, de imediato, os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com as homenagens de estilo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC, haja vista que não cabe ao juízo de 1º grau a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CASSIA MULLER, Juíza de Direito**, em 12/03/2025, às 16:38:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10078418466v6** e o código CRC **e6dac8bf**.

---

1. Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças

listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; ↩